Protocolo de Bioseguridad

Quiz · Para: Intermedio (semisénior) · Fidelidad a la fuente: 100%

Introducción

Pregunta 1. ¿Cuál es el impacto principal de implementar de manera rigurosa los protocolos de bioseguridad en un establecimiento de salud?

A) Reemplaza la necesidad de segregar los residuos en el punto de generación.

B) Permite prescindir de la capacitación periódica del personal con experiencia clínica previa.

C) Elimina totalmente los riesgos físicos y químicos sin requerir equipos de protección personal.

D) Reduce de forma significativa la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria y protege al personal de exposiciones innecesarias.

Higiene de manos

Pregunta 2. Al establecer la lógica de control para la higiene de manos, ¿en qué condición es aceptable recurrir a una solución a base de alcohol en gel en lugar de agua y jabón?

A) Solo antes de procedimientos quirúrgicos invasivos en sustitución definitiva del agua y jabón.

B) Siempre que las manos no estén visiblemente sucias, manteniendo la fricción hasta que el producto se seque por completo.

C) En cualquier escenario con suciedad visible si se efectúa una doble aplicación consecutiva.

D) Únicamente si el tiempo de aplicación se reduce a menos de diez segundos para agilizar el flujo de atención.

Equipo de protección personal (EPP)

Pregunta 3. ¿Qué riesgo operativo describe el protocolo cuando los guantes se reutilizan entre pacientes o se portan durante tareas administrativas?

A) Facilita el flujo de trabajo clínico sin requerir retiro ni sustitución entre actividades.

B) Sustituye formalmente la obligación de realizar higiene de manos antes y después de cada procedimiento.

C) Anula su función protectora y puede convertirlos en un vector de contaminación cruzada.

D) Conserva intacta su barrera protectora si se desinfectan superficialmente con alcohol.

Pregunta 4. Para evitar el contacto de superficies contaminadas con la piel o la ropa, ¿cuál es el orden estricto establecido para la retirada del EPP?

A) Primero los guantes, luego la protección ocular, la bata y finalmente la mascarilla.

B) Primero la protección ocular, luego los guantes, la mascarilla y finalmente la bata.

C) Primero la mascarilla, luego la bata, la protección ocular y finalmente los guantes.

D) Primero la bata, luego los guantes, la mascarilla y la protección ocular.

Manejo de residuos biocontaminados

Pregunta 5. ¿Cómo deben manejarse y descartarse los residuos punzocortantes, tales como agujas y hojas de bisturí, en el punto de generación?

A) Reencapuchando las agujas antes de disponerlas en bolsas rojas de residuos biocontaminados comunes.

B) Disponiéndolos en bateas abiertas para su consolidación al término del turno asistencial.

C) Forzando manualmente su ingreso en contenedores flexibles para maximizar el volumen de acopio.

D) Descartándolos de inmediato en contenedores rígidos resistentes a punción, sin reencapuchar agujas y sin forzar su entrada si se alcanza el límite indicado.

Limpieza y desinfección de superficies

Pregunta 6. ¿Por qué la limpieza física debe preceder siempre al proceso de desinfección en las superficies hospitalarias?

A) Porque los agentes desinfectantes eliminan de forma mecánica la suciedad visible sin requerir fricción previa.

B) Porque el fabricante exige aplicar el desinfectante únicamente sobre superficies con polvo acumulado.

C) Porque la materia orgánica remanente puede inactivar parcialmente algunos desinfectantes químicos.

D) Porque la desinfección solo está autorizada reglamentariamente para superficies de bajo contacto.

Notificación de incidentes y exposiciones

Pregunta 7. Ante una punción accidental o salpicadura de fluidos corporales a mucosas, ¿cuál es el objetivo clave de notificar de inmediato a salud ocupacional?

A) Permitir la evaluación de riesgo e intervenciones dentro de ventanas de tiempo recomendadas, además de alimentar el registro epidemiológico interno.

B) Sustituir el lavado de manos estándar por protocolos de desinfección ambiental.

C) Proceder a la incineración de todos los equipos de protección usados durante la jornada asistencial.

D) Eximir al personal de cumplir con los circuitos de traslado de residuos biocontaminados.

Capacitación continua del personal

Pregunta 8. ¿Qué criterio pedagógico e institucional garantiza que los programas de capacitación en bioseguridad reduzcan efectivamente los incidentes de forma sostenida?

A) Limitar la formación a una sesión teórica única impartida durante la inducción inicial.

B) Mantener programas periódicos, continuos y verificables que evalúen el conocimiento adquirido.

C) Distribuir manuales escritos prescindiendo de evaluaciones o registros de seguimiento.

D) Registrar exclusivamente la lista de asistencia a charlas sin comprobar el aprendizaje.

Respuestas

1. D) Reduce de forma significativa la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria y protege al personal de exposiciones innecesarias.

El documento indica que aplicar correctamente los protocolos de bioseguridad hospitalaria reduce de forma significativa las infecciones asociadas a la atención sanitaria y protege a los profesionales frente a exposiciones innecesarias a riesgos biológicos, físicos y químicos.

2. B) Siempre que las manos no estén visiblemente sucias, manteniendo la fricción hasta que el producto se seque por completo.

El documento señala que el alcohol en gel es una alternativa aceptable cuando no se dispone de agua y jabón, siempre que las manos no estén visiblemente sucias y manteniendo la fricción sobre palmas, dorso, espacios interdigitales y uñas hasta secarse por completo.

3. C) Anula su función protectora y puede convertirlos en un vector de contaminación cruzada.

El documento advierte expresamente que reutilizar guantes entre pacientes distintos, o usarlos durante tareas administrativas ajenas al procedimiento, anula su función protectora y puede convertirlos en un vector de contaminación cruzada.

4. A) Primero los guantes, luego la protección ocular, la bata y finalmente la mascarilla.

El protocolo define que para retirar el equipo se prioriza evitar el contacto contaminante retirando primero los guantes, luego la protección ocular, la bata y finalmente la mascarilla, ejecutando higiene de manos tras cada elemento retirado.

5. D) Descartándolos de inmediato en contenedores rígidos resistentes a punción, sin reencapuchar agujas y sin forzar su entrada si se alcanza el límite indicado.

Según el documento, los punzocortantes deben ser descartados de inmediato en contenedores rígidos resistentes a punción, sin reencapuchar las agujas y sin forzar su entrada cuando el contenedor llega a su límite indicado.

6. C) Porque la materia orgánica remanente puede inactivar parcialmente algunos desinfectantes químicos.

La limpieza y la desinfección son procesos distintos y secuenciales: una superficie debe limpiarse antes de desinfectarse debido a que la materia orgánica puede inactivar parcialmente algunos desinfectantes químicos.

7. A) Permitir la evaluación de riesgo e intervenciones dentro de ventanas de tiempo recomendadas, además de alimentar el registro epidemiológico interno.

La notificación oportuna ante una exposición a fluidos corporales permite iniciar la evaluación de riesgo y las medidas pertinentes dentro de las ventanas de tiempo recomendadas, además de nutrir el registro epidemiológico interno que impulsa la mejora continua.

8. B) Mantener programas periódicos, continuos y verificables que evalúen el conocimiento adquirido.

El documento explica que los establecimientos que logran reducir incidentes de forma sostenida

son aquellos que implementan programas de capacitación continua y verificable, con evaluación del conocimiento adquirido y no limitándose a la mera asistencia o a una inducción inicial.